

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Data da Aprovação	Próxima Revisão	Versão	Rotina	Página
05/09/2023	05/09/2025	nº 01	nº 29	01 à 04
Nome do Procedimento: Encaminhamento para realização de Punção Lombar no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt – HRHDS na suspeita de neurosífilis.				
Diretoria: Diretoria de Assistência à Saúde e Direção Técnica.				
Gerência: Gerência de Distritos da Atenção Primária.				
Serviço: Atenção Primária à Saúde, Ligue Web Saúde, Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS).				
Executantes: Médicos que atuam na assistência, profissionais do Ligue Web Saúde da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), NIR Hospital Regional Hans Dieter Schmidt.				
Objetivo: Orientar o passo a passo para encaminhar o usuário com suspeita de neurosífilis para Punção Lombar no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS).				
Recursos necessários: ✓ Equipamentos de informática; ✓ Acesso à internet; ✓ Sistema Integrado de Gestão - SIG Saúde Tech; ✓ E-mail institucional, com devido cadastro de profissionais e impressora.				

CONCEITO

O termo neurosífilis refere-se à infecção do sistema nervoso central (SNC) pelo *Treponema pallidum*, e pode ocorrer a qualquer momento após a infecção inicial, sendo mais comum o aparecimento tardio. Na fase aguda, a sintomatologia pode envolver o líquido cefalorraquidiano (LCR), meninges (meningite assintomática, meningite sintomática) e vasculatura (doença meningovascular). Na fase tardia da doença, as formas mais comuns envolvem o parênquima cerebral e a medula espinhal.

O diagnóstico de neurosífilis se dá através de punção lombar, entretanto, as diretrizes atuais, não recomendam a punção lombar em pacientes que não apresentem sintomas neurológicos, otológicos ou oculares

DESCRIÇÃO

Médico solicitante da UBSF

- Descartar outras doenças do SNC solicitando os exames abaixo:
- ✓ Hemograma completo;
- ✓ Tempo de Atividade da Protrombina (TAP);
- ✓ Tomografia de crânio com contraste **APENAS** para usuários com:

Estado mental alterado	Papiledema
Déficits neurológicos focais	Idade ≥ 60
História de doença do sistema nervoso central	Crises convulsivas na última semana

Imunodeficiência (HIV, uso de imunossuppressores, transplantados)	Alta suspeita clínica de hemorragia subaracnóidea
---	---

- Solicitar punção lombar via formulário livre no Sistema Integrado de Gestão SIG Saúde Tech;
- Encaminhar e-mail para o Ligue WEB Saúde (ses.enf.lws@joinville.sc.gov.br), com os seguintes dados do usuário:

Título do e-mail:

- ✓ Solicitação punção lombar e matrícula do Sistema SIG-Saúde tech
- Descritivo do e-mail:
- ✓ Nome completo;
 - ✓ Matrícula do sistema eletrônico;
 - ✓ Data de Nascimento;
 - ✓ Nome da mãe;
 - ✓ Telefone de contato;
 - ✓ Relato do caso com medicamentos em uso e informação se usuário imunocompetente ou imunodeprimidos;

Anexar:

- ✓ Solicitação de punção lombar realizado no sistema eletrônico.
- ✓ Resultado dos exames.

Ligue Web Saúde

- Médico ou enfermeiro do Ligue Web Saúde confere os dados encaminhados por e-mail.
- ✓ E-mail em desacordo ou com dúvidas, será devolvido com considerações;
- ✓ E-mail correto: será encaminhado para o e-mail do HRHDS (nirhrhds@saude.sc.gov.br).

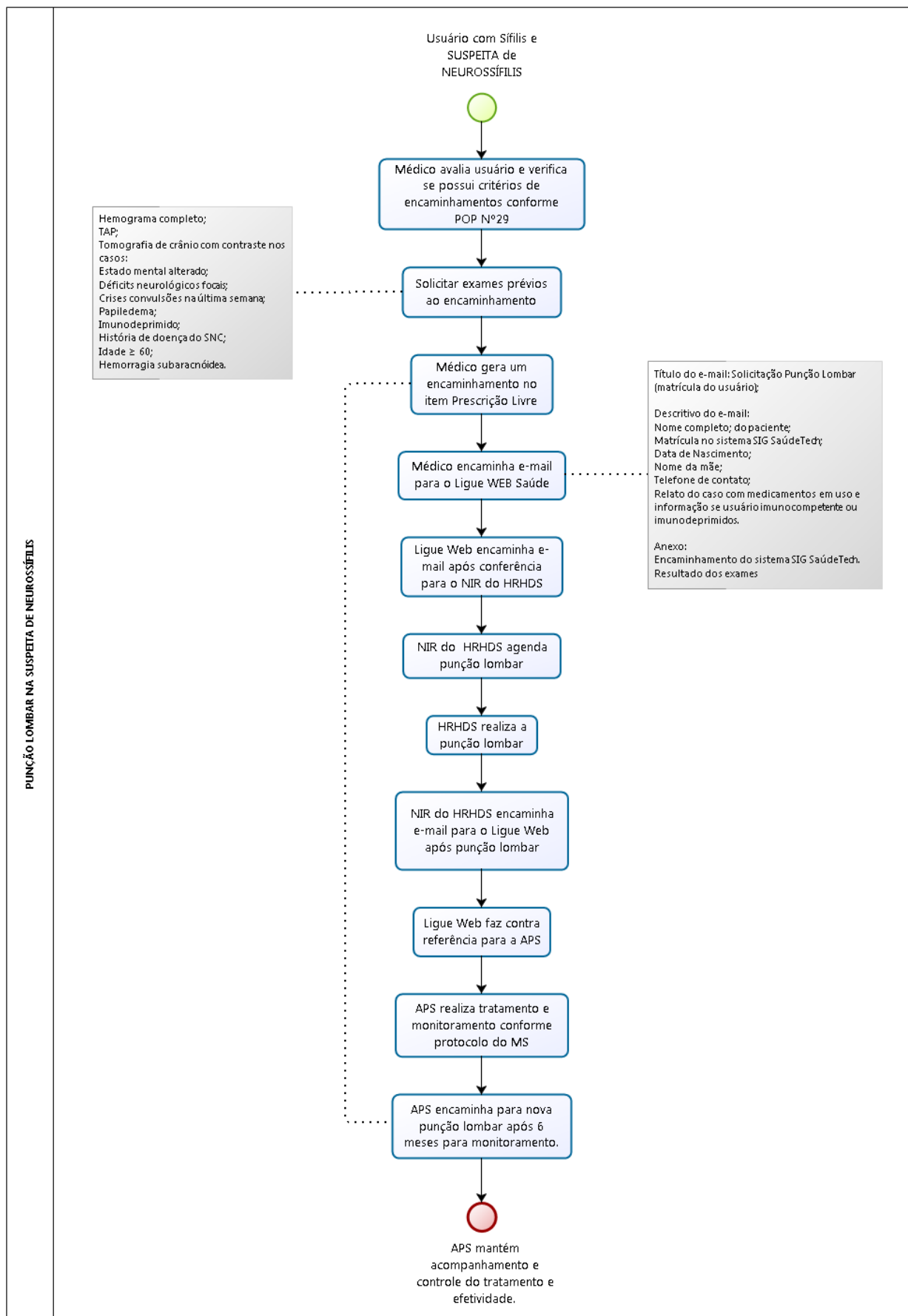
Núcleo Interno de Regulação – NIR do HRHDS

- Após recebimento do e-mail, o HRHDS realiza os encaminhamentos internos para o agendamento diretamente com o usuário e registrar em prontuário. Nos casos de falha no contato, registrar em prontuário as tentativas de agendamento;
- Após a punção lombar, o NIR deve encaminhar e-mail para o Ligue WEB, informando a realização do procedimento para conduta e tratamento na UBSF de referência do usuário.

Ligue Web Saúde

- **Após retorno do NIR:** Médico ou enfermeiro recebe o e-mail, e realiza a contrarreferência do usuário para UBSF.

Figura 1 – Fluxograma de encaminhamento para Punção Lombar, na suspeita de neurosífilis.



REFERÊNCIAS

1. Rodrigo Antônio Brandão Neto, Médico Assistente da Disciplina de Emergências Clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. **Neurossífilis**. 07/01/2020. Disponível em <https://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/7799/neurossifilis.htm>. Acessado em janeiro 2023;
2. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022;
3. Gao ZX, Gou Y, Liu XQ, Peng LW. Advances in laboratory diagnostic methods for cerebrospinal fluid testing for neurosyphilis. *Front Public Health*. 2022 Nov 14;10:1030480. doi: 10.3389/fpubh.2022.1030480;
4. Zhou J, Zhang H, Tang K, Liu R, Li J. An Updated Review of Recent Advances in Neurosyphilis. *Front Med (Lausanne)*. 2022 Sep 20;9:800383. doi: 10.3389/fmed.2022.800383;
5. Boog GHP, Lopes JVZ, Mahler JV, Solti M, Kawahara LT, Teng AK, Munhoz JVT, Levin AS. Diagnostic tools for neurosyphilis: a systematic review. *BMC Infect Dis*. 2021 Jun 14;21(1):568. doi: 10.1186/s12879-021-06264-8;
6. Gorelick, P.B., Testai, F.D., Hankey, G.J., & Wardlaw, J.M. (Eds.). (2020). *Hankey's Clinical Neurology* (3rd ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9780429299476>;
7. Davis AP, Stern J, Tantaló L, Sahi S, Holte S, Dunaway S, Marra CM. How Well Do Neurologic Symptoms Identify Individuals With Neurosyphilis? *Clin Infect Dis*. 2018 Jan 18;66(3):363-367. doi: 10.1093/cid/cix799;
8. Tunkel AR, Hartman BJ, Kaplan SL, Kaufman BA, Roos KL, Scheld WM, Whitley RJ. Practice guidelines for the management of bacterial meningitis. *Clin Infect Dis*. 2004 Nov 1;39(9):1267-84. doi: 10.1086/425368;
9. van de Beek D, Cabellos C, Dzupova O, Esposito S, Klein M, Kloek AT, Leib SL, Mourvillier B, Ostergaard C, Pagliano P, Pfister HW, Read RC, Sipahi OR, Brouwer MC; ESCMID Study Group for Infections of the Brain (ESGIB). ESCMID guideline: diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis. *Clin Microbiol Infect*. 2016 May;22 Suppl 3:S37-62. doi: 10.1016/j.cmi.2016.01.007;
10. April MD, Long B, Koyfman A. Emergency Medicine Myths: Computed Tomography of the Head Prior to Lumbar Puncture in Adults with Suspected Bacterial Meningitis - Due Diligence or Antiquated Practice? *J Emerg Med*. 2017 Sep;53(3):313-321. doi: 10.1016/j.jemermed.2017.04.032;
11. Salazar L, Hasbun R. Cranial Imaging Before Lumbar Puncture in Adults With Community-Acquired Meningitis: Clinical Utility and Adherence to the Infectious Diseases Society of America Guidelines. *Clin Infect Dis*. 2017 Jun 15;64(12):1657-1662.

Fonte: NGA, SMS, 2023.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2023 Janaina Pravato Vicente Banin	Adriane Schewinski Amélia Vieira Fabiane Cherobim Fabiane Guizoni Gabriela Cristina da Silva Brandão Manuelle Hölscher Belz Marcelo Mulazani Maria da Graça P. de Lima Assef Maria Simone Pam	Maristela Mello de Aguiar Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível pelo Endereço Eletrônico

Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 23.0.229082-2



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

